

	COORDINACIÓN CLÍNICA		CC -	Versión 1
	FORMATO DE DILIGENCIAMIENTO DE HISTORIA CLÍNICA		Fecha Emisión 26/01/2024	Fecha actualización 08/04/2024
			Pag 1 de 4	Aplicación: Bogotá

	Niños	Adultos
Motivo de consulta Debe incluir:	*Remitido por *MC del remitente (razón o sospecha sugerida por orden médica). *Queja subjetiva (descripción del usuario o su acompañante). *Enfermedad actual (problemática puntual). *Evolución del cuadro (inicio de síntomas y condición actual de manera puntual, se ampliará en los otros apartados).	
Riesgos pre/perinatales/ Desarrollo	Condiciones clínicas que se reportan durante el periodo de gestación hasta las dos primeras semanas posteriores al parto: CPN+/- (Controles prenatales + si tuvo, - si no tuvo) SFA: (sufrimiento fetal), preeclampsia, IVU's (infecciones de vías urinarias) maternas, RCIU (retención en el crecimiento intrauterino), estrés materno, incubadora, hipoxia. Ucin (unidad de cuidados intensivos neonatales), plan canguro, fototerapia. Inducción (incluso si fue fallida), tipo de parto (vaginal, vaginal instrumentado, cesárea programada, cesárea urgencias, cesárea iterativa o de repetición). Hidro-oligoamnios (pérdida del líquido amniótico). Distocia (por macrosomía, podálico, de hombros, etc.) Meconio. NS: no sabe, (Va en pestaña de riesgos). Código rojo o condiciones de la madre que pudieran afectar la estimulación del niño. Desarrollo: hitos en meses, si no sabe la edad indicar si fue Demora/Normal (peso normal es de 2500 hacia arriba, preguntar si estuvo en plan canguro por debajo de 2500 gr). Peso y talla: gramos y centímetros, si no lo sabe Bajo/ normal. Control de esfínteres: diurno y nocturno, si no recuerdan cuándo si el diurno supera los 3 años poner demora.	Indagar condiciones que afectaron el desarrollo en casos de discapacidad o sospecha de trastorno del neurodesarrollo en el adulto y se tiene el informante. Si no hay un buen informante se pone en apartado de Patológicos: Desarrollo y se hace el reporte resumido (p.e. indican demoras en el desarrollo del lenguaje).
Patológicos/ médicos	Enfermedades médicas agudas de importancia previas y/o actuales (Neumonía, bronquiolitis, otitis, amigdalitis, convulsiones febriles, displasia de cadera, espasmo del sollozo), así como en enfermedades actuales (gastroenteritis, epilepsia, estreñimiento, parálisis cerebral, migrañas, DM, síncope, anemia, enfermedades genéticas, tumores), discapacidad intelectual asociada a condición específica (sindrómica), hipertrofias (adenoides, amígdalas, cornetes), otras condiciones médicas/neurológicas/genéticas, IRAS, COVID-19, AOS (Apnea obstructiva del sueño). Edad menarquia, SOP: Síndrome de ovario poliquístico. Si es un Dx. en estudio o diferencial indicarlo, y si lo toma de HC, indicar de dónde y entre comillas.	Enfermedades médicas agudas y crónicas (HTA: Hipertensión Arterial, hipotiroidismo, DM: Diabetes Mellitus, enfermedades renales, coronarias, fibromialgia, CA: Cáncer/carcinoma, enfermedades osteomusculares, cefaleas, migrañas, EM: Esclerosis Múltiple, ECV: Enfermedad Cerebrovascular, ACV: Accidente Cerebrovascular, neoplasias) y otras enfermedades médicas /neurológicas/genéticas, COVID-19. Si son mujeres preguntar número de embarazos GPA (Gestaciones Partos Abortos p.e. G0P0A0), EPOC, AOS (Apnea obstructiva del sueño). TCE: indicar condiciones asociadas y secuelas (Tiempo del coma, Glasgow, Amnesia retrograda y anterógrada, línea de tiempo, tiempo de hx y periodo de confusión).

		Si es un Dx. en estudio o diferencial indicarlo, y si lo toma de HC, indicar de dónde y entre comillas.
Sensoriales/ Motores	Aspectos extrapiramidales del movimiento y alteraciones periféricas sensoriales o corticales primarias. Hipotonía, hiperlaxitud, hipoacusia (uso de audífono), limitaciones visuales (miopía, ambliopía, estrabismo, hipermetropía, astigmatismo), visión corregida con lentes, problemas con la coordinación o equilibrio.	Aspectos extrapiramidales del movimiento y alteraciones periféricas sensoriales o corticales primarias. Vértigo, pérdida de equilibrio, temblores, hipoacusia (uso de audífonos), limitaciones visuales (miopía, ambliopía, estrabismo, hipermetropía, astigmatismo), limitaciones motoras (hemiparesia), visión corregida con lentes
Alérgicos	Alergias atópicas Rinitis, Dermatitis, Asma, Medicamentos, alimentos (gluten, proteína de la leche, etc.).	
Tóxicos	Biomasa (madera, carbón), fumadores pasivos, quimioterapia, radioterapia, Alcohol, cigarrillo, SPA, exposición a químicos, electromagnetismo. Si trabajaba en el campo o vive en el campo indagar por organofosforados y plaguicidas/herbicidas.	
Psiquiátricos	Enfermedades diagnosticadas desde psiquiatría o que hacen parte de los trastornos psiquiátricos (Autismo, TDAH, Gilles de la Tourette, Ansiedad, Depresión, Esquizofrenia, Trastornos de personalidad, TOC, etc.), Discapacidad intelectual no sindrómica (No asociada a cuadro genético o médico).	
Terapéuticos	Se incluyen procesos previos y/o actuales, si hubo continuidad y efectos. PIR: Plan integral de rehabilitación.	
Quirúrgicos	Se incluyen cirugías menores y mayores y tipo de anestesia.	
Farmacológicos	Se incluyen medicamentos actuales (tabletas, gotas, tópicos, inhaladores). Usar nombres con mayúscula inicial y corroborar su ortografía. Uso crónico de Benzodiacepinas, medicamentos homeopáticos o alternativos.	
Traumáticos	Principalmente se refiere a TCE con o sin pérdida de conciencia (tipo de accidente, fecha aproximada, si fue mayor y con secuelas se describe en patológicos), indicar si hubo fracturas u otro tipo de traumatismos.	
Familiares	Se incluyen antecedentes en núcleo familiar (padres, hermanos y abuelos) médicos/neurológicos/psiquiátricos y en familia extensa neurológicos/psiquiátricos se debe indicar la línea (materna y paterna), el miembro de la familia afectado y hasta tercer grado de consanguinidad.	
Paraclínicos	Se incluyen imágenes diagnósticas del cerebro (indicar qué tipo iRM de cerebro- TAC de cráneo simple o con contraste, polisomnografías, EEG/telemetrías, resultados de pruebas genéticas y de laboratorio relevantes, audiometrías, potenciales evocados, pruebas neuropsicológicas (indicar tipo de examen, año y principales resultados como Índices si fue el WISC/WAIS).	
Áreas de funcionalidad		
Vive con-Familiar	Con quién vive, Nombre y edad de los padres/acudientes, nivel educativo y ciudad de nacimiento de los padres (p.e Bogotá, Postgrado), edad de los hermanos, estado de relación del núcleo familiar. Cuidador principal, Conductas parentales (formas de corrección, acuerdos entre los padres, respuesta del menor en casa).	Con quién vive, si corresponde; quien es el cuidador principal, cantidad de hijos, edad de los hijos. Dinámicas relacionales, si hay o no red de apoyo primaria.
ABC	ABVD: Adquisición de Independencia (Levantarse, Acostarse, Realizar el aseo personal, limpiarse solo al ir al baño, bañarse solo o con supervisión, lavarse el cabello, Vestirse, Comer por sí mismo), en estos procesos indicar si se ata cordones, se abotona, qué cubiertos usa. Instrumentales: Tareas en el hogar (tender la cama, recoger juguetes, lavar la loza, etc.), montar bicicleta o patines, coordinación y equilibrio en deportes y	ABVD: Levantarse, Acostarse, Realizar el aseo personal, Vestirse, Comer por sí mismo, Caminar. AIVD: nivel instrumental: Limpiar, Lavar, Cocinar, Hacer las compras, Manejar dinero, Desplazarse por la calle, Utilizar los transportes, Hacer gestiones, Ir al médico, Controlar la medicación, Riesgo de accidentes caseros,

	actividades, Reconocimiento y manejo del dinero (acorde a la edad), sale solo o cocina (depende de la edad). Enuresis o encopresis.	maneja vehículo, orientación temporal y espacial. AAVD: tiempo de ocio, conseguir trabajo, manejar las finanzas.
Escolar/ Laboral	Adaptación a etapa escolar, si tuvo preescolar/aprestamiento. Nombre del colegio. Rendimiento académico, colegio público o privado, si tiene adaptación curricular/inclusión, edad de escolarización, cambios de colegio, materias con y/o sin dificultades, pérdidas de año, adaptación actual al colegio.	Nivel educativo (Profesión o estudios) o grado de analfabetismo, Historia laboral resumida (para reconocer habilidades) en qué trabaja/trabajó, Rendimiento o afectación laboral, Edad de retiro o pensión.
Funciones Cognitivas	Se debe indicar con ejemplos las quejas cognitivas por áreas (no interpretar a qué función se asocia, p.e. no poner fallas de memoria de trabajo, si no la falla que indica), no describir lo que no tiene si no lo que sí (p.e. NO decir: no tiene dificultades, si no indicar adecuados procesos, o "No tiene problemas de regulación" si no "Se regula en entornos sociales...") Atención: Si se distrae, enfoca, termina con concentración los procesos, le cuesta concentrarse, en qué contextos y con qué estímulos, termina lo que empieza. -Desarrollo del lenguaje: Demoras, expresivo (dislalias después de los 4 años, si están presentes en el momento en el área de neurodesarrollo se pone en la categoría lenguaje claro "No"), comprensivo (entiende instrucciones, las pierde, responde lo que le preguntan apropiadamente), lectura y escritura (indicar el tipo de fallos en estos procesos). - Memoria: Recuerda lo que le enseñan y/o le dicen, los aprendizajes escolares, episódicos o de lugares y personas. -Praxias/Gnosias: motricidad fina (corta con tijeras, rasga papel, hace pinza), motricidad gruesa (corre, salta, trepa, sube y baja escaleras, puede armar rompecabezas), dibujo, escritura. Confusión con elementos o figuras geométricas, reconocimiento colores. -Funciones ejecutivas: Hace cálculos matemáticos (describir los tipos de fallos), puede hacer análisis y operaciones mentales Cognición social, comprensión de chistes, entiende normas sociales, se ajusta a los entornos o hay cambios en su comportamiento dependiente del contexto, es organizado.	Se debe indicar con ejemplos las quejas cognitivas por áreas (no interpretar a qué función se asocia, p.e. no poner fallas de memoria de trabajo, si no la falla que indica), no describir lo que no tiene si no lo que sí (p.e. NO decir: no tiene dificultades, si no indicar adecuados procesos, o "No tiene problemas de regulación" si no "Se regula en entornos sociales..."): -Atención: Se enfoca, se distrae, pierde el hilo, olvida lo que va a hacer en un inicio, se cansa ante tareas extensas, se demora más haciendo las cosas que antes -Lenguaje: expresivo (disartria, anomias, parafasias), comprensivo, lectura y escritura, ortografía. - Memoria: olvidos recientes o antiguos, episódicos, olvido de nombres, fechas importantes o citas, repite lo mismo, se le pierden las cosas. -Praxias y Gnosias: ¿Ha tenido cambios en la percepción, torpeza, tumbar objetos al tratar de tomarlos, caídas, rigidez, dificultad para hacer cosas que hacía antes como recordar el uso de herramientas o cómo cocinar? -Funciones ejecutivas: Razonamiento, Hace cuentas, uso de la retroalimentación, flexibilidad cognitiva, le cuesta organizar actividades, ha manifestado impulsividad o cambios en su patrón de conducta, puede hacer análisis y operaciones mentales, Cognición social, comprensión de chistes o conductas inapropiadas al contexto.
Comportamiento	Dependiendo de la condición o hipótesis diagnóstica se debe profundizar en algunos aspectos, desde lo clínico se debe indagar por incrementos, disminuciones en la conducta, o manifestaciones que generan interferencia sobre la misma, teniendo en cuenta frecuencia, duración e intensidad de los síntomas. Es importante registrar: Impulsividad (si mide riesgos, es imprudente, no espera su turno), inquietud motora o hiperactividad, relaciones sociales,	Dependiendo de la condición o hipótesis diagnóstica se debe profundizar en algunos aspectos, desde lo clínico se debe indagar por incrementos, disminuciones en la conducta, o manifestaciones que generan interferencia sobre la misma, teniendo en cuenta frecuencia, duración e intensidad de los síntomas. Esfera emocional, síntomas como ansiedad o depresión, desde cuándo, eventos vitales asociados. Cambios en comportamiento o

	seguimiento de órdenes, tolerancia a la frustración, ansiedad (síntomas como preocupación, temores, miedos, angustia y en ¿qué situaciones?), tristeza (suele ser más evidente los síntomas de ansiedad que de depresión en los niños, y las manifestaciones pueden ser más conductuales que emocionales). Eventos vitales relevantes (separación de los padres, cambio de residencia o colegio, pérdida de algún miembro de la familia). Alteraciones en la conducta (agresividad, irritabilidad). Alteraciones en la percepción (texturas, olores, sonidos). Movimientos o conductas repetitivas (estereotipias, tics, etc.). En general aspectos descriptivos revisados en TEA.	acentuación de rasgos de personalidad como Irritabilidad, agresividad, impulsividad rigidez, presencia de alucinaciones o ilusiones, conducta sexual inadecuada, apatía, anhedonia, delirios, suspicacia. Desinhibición.
Patrón de sueño	Describir el patrón de sueño, No poner normal. Indicar horas de sueño, facilidad para conciliar, si es un sueño continuo y reparador. Duerme solo o acompañado (colechó), Respiración (ronca, AOS), Parasomnias (sonambulismo, tics, hablar, reír, somniloquios), Terrores nocturnos o pesadillas. Bruxismo, siestas, somnolencia diurna, levantarse con ojeras, hipersomnia.	Describir el patrón de sueño, No poner normal. Indicar horas de sueño, facilidad para conciliar, si es un sueño continuo y reparador. Despertares en la noche, reconciliación o despertar temprano con respecto a horas de sueño. Respiración (Ronca, AOS, uso de C/B-PAP u Oxígeno), Parasomnias (sonambulismo, tics, hablar, reír, somniloquios, movimientos), Trastornos del sueño: p.e Piernas inquietas, bruxismo, Terrores nocturnos, alteración del sueño REM, parasomnias. Siestas o somnolencia diurna.
Alimentación	Patrón de alimentación: si es balanceado (todos los grupos alimenticios). Si hay selectividad por texturas/olores o formas en la comida, si come verduras o frutas, si tiene alguna dieta (Cetogénica, alergias alimentarias, etc.). Patrón en exceso o en defecto (hiperfagia o hipofagia, anorexia, ansiedad por comer). Si se demora comiendo, mastica o acumula, se pasa la comida, se distrae comiendo.	Patrón de alimentación: si es balanceado (todos los grupos alimenticios) Si tiene alguna dieta (Cetogénica, alergias alimentarias, hiposódicas, bajas en grasa etc.). Patrón en exceso o en defecto (hiperfagia o hipofagia, anorexia, ansiedad por comer, hiperoralidad). Cantidad, aumento o disminución del apetito. Pérdida de peso inexplicable o muy rápida, preferencia por algunos alimentos, consumo excesivo de líquidos, carbohidratos o algún tipo de alimento, PICA diagnosticada.

Elaboro: 26/01/2023	Revisó: 26/01/2024	Aprobó: 26/01/2024
Cargo: Coordinación Clínica	Cargo: Dirección Clínica	Cargo: Dirección Clínica
Nombre: Kely Bonilla/María Rojas	Nombre: María Cristina Pinto	Nombre: Ma. Cristina Pinto/ Susana Lozano